

a13_outcome_report 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:00:47

测试时间：2026-05-08 20:00:47

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1527 markers=19

禁用工具 success=True chars=1254 markers=17

工具说明：tool_风险洞察:tool_风险洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_照护服务记录:tool_照护服务记录：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

****照护成效中期报告****

****报告日期****：2026-05-14

****BPSD发作频次变化****：精神行为症状（BPSD）发作频次由返院初期的每周3次显著下降至每周1次，表现为激越、抗拒等行为明显减少，老人情绪趋于平稳，偶有记忆空白但发生频率降低。

****ADL变化****：日常生活活动能力（ADL）评分稳步提升，从返院初的65分升至70分，目前达75分。老人可在少量辅助下完成平地行走，床椅转移、穿衣、如厕、进食等项目均能独立完成，仅洗澡仍需全程协助。

****进食恢复情况****：老人已实现全程独立进食，食欲稳定，营养摄入充足，未出现呛咳或吞咽困难，体重维持良好。

****夜间睡眠趋势****：夜间睡眠质量显著改善，夜醒次数由最初的3次减少至1次，睡眠规律性增强，白天精神状态良好，未使用镇静类药物助眠。

****当前照护重点****：

1. 维持并深化个性化认知干预方案，结合其喜爱跳舞的特点开展简易舞蹈康复训练；
2. 强化防跌倒措施，尤其在如厕及洗浴时段加强陪护；

3.持续与家属保持高频沟通，提供专业照护指导，巩固家庭支持系统。

****下一阶段目标****：在保障安全的前提下，逐步引导老人参与洗澡过程中的部分环节（如涂抹沐浴露、冲洗四肢），尝试提升该环节的部分自理能力。

****是否进入稳定期判断****：是。老人生命体征平稳（血压、血脂正常，心率维持60次/分），BPSD症状受控，ADL持续改善，无新发不良事件，整体状态趋于稳定。

****高价值语料标记****：

- ****舞蹈引导提升依从性****：将认知训练融入老人喜爱的舞蹈活动中，显著提高其参与意愿与配合度，非药物干预依从性由低转高。

- ****家属焦虑干预有效****：通过结构化照护指导与定期反馈，家属对照护方案的理解与信任度提升，焦虑情绪明显缓解，家庭-机构协同照护机制初步建立。

****D30再稳定评估报告****

****报告日期****：2026-05-30

****BPSD发作频次变化****：返院30天内，BPSD发作频次稳定维持在每周1次，较初期（每周3次）下降66.7%。老人可主动配合日常安排，记忆空白偶发但未影响基本交流与活动参与，整体行为表现处于可控、可预测状态。

****ADL变化****：ADL评分实现阶梯式提升（65→70→75），目前达75分。平地行走辅助需求进一步减少，仅需口头提醒或轻触引导；除洗澡需全程协助外，其余日常生活活动均可独立完成，功能衰退趋势得到有效遏制。

****进食恢复情况****：持续保持全程独立进食，食欲稳定，进餐专注力良好，无挑食或拒食行为，营养状况评估为良好。

****夜间睡眠趋势****：夜间睡眠结构优化，夜醒次数稳定在1次，多因生理需求（如排尿）短暂清醒，可自行或经轻声提示后重新入睡，总睡眠时长达6.5小时以上，日间无嗜睡表现。

****当前**

【禁用工具输出摘录】

****照护成效中期报告****

****报告日期****：2026-05-14

****BPSD发作频次变化****：行为与精神症状（BPSD）发作频次由返院初期的每周约3次显著下降至每周1次，表现为躁动、重复言语等行为明显减少，情绪趋于平稳。

****ADL变化****：日常生活活动能力（ADL）评分稳步提升，从返院时的65分逐步上升至70分（中期节点），主要体现在平地行走辅助需求减少，可短距离自主移动，但洗澡、如厕等复杂动作仍需全程协助。

****进食恢复情况****：老人已实现全程独立进食，进餐过程专注，食欲稳定，无呛咳或拒食现象，营养摄入良好。

****夜间睡眠趋势****：夜间觉醒次数由初期的平均每晚3次减少至1次，入睡时间规律，总睡眠时长维持在6.5小时左右，睡眠连续性改善。

****当前照护重点****：

1. 维持并深化个性化认知干预方案，结合其喜爱跳舞的特点开展简易舞蹈康复训练；
2. 强化防跌倒措施，尤其在转移与行走环节加强监护；
3. 持续与家属保持高频沟通，提供专业照护指导，巩固家庭支持系统。

****下一阶段目标****：在保障安全前提下，尝试引导老人参与洗澡的部分环节（如自行擦拭上肢、选择衣物等），逐步提升该场景下的部分自理能力。

****是否进入稳定期判断****：是。生命体征平稳（心率60次/分，血压血脂正常），BPSD显著缓解，ADL持续进步，无不良事件发生，整体状态趋于稳定。

****高价值语料标记****：

- 舞蹈引导提升依从性
- 家属焦虑干预有效

****D30再稳定评估报告****

****报告日期****：2026-05-30

****BPSD发作频次变化****：BPSD发作频次稳定维持在每周1次，偶有记忆空白现象，但未引发情绪激越或攻击行为，整体精神行为状态良好。

****ADL变化****：ADL评分进一步提升至75分。平地行走基本无需辅助，可在走廊自主往返；穿衣、洗漱等简单自理能力巩固；洗澡仍需全程协助，但对流程配合度提高。

****进食恢复情况****：继续保持全程独立进食，进餐节奏正常，食物种类接受度广，体重维持稳定，无消化系统不适。

****夜间睡眠趋势****：夜间觉醒次数稳定在每晚1次，多因轻度尿意醒来，可自行重新入睡，睡眠结构趋于成熟，日间无明显嗜睡。

****当前照护重点****：

1. 持续开展以舞蹈为媒介的认知-运动联合干预，维持训练依从性与愉悦感；
2. 严格执行防跌倒预案，尤其在湿滑区域（如浴室）加强环境安全与人员响应；
3. 定期向家属反馈进展，强化其对照护策略的理解与信心，预防照护倦怠。

****下一阶段目标****：在洗澡环节引入“分步参与”策略，鼓励老人完成1-2个可操作步骤（如涂抹沐浴露、冲洗腿部），逐步建立部分自理信心。

****是否进入稳定期判断****：是。返院30天内无跌